

## B 咳喘息 cough variant asthma

### 到達目標

- 慢性咳嗽の概略を説明できる
- 咳喘息の定義・頻度、臨床像・検査所見・診断基準を説明できる
- 咳喘息の重症度に応じた治療を説明できる

### 病因・病態・疫学<sup>1,2)</sup>

咳喘息は、喘鳴や呼吸困難を伴わない咳、気道過敏性亢進、気管支拡張薬の有効性を特徴とする喘息の亜型（咳だけが症状の喘息）である。副鼻腔気管支症候群、胃食道逆流症などを凌いで本邦の慢性咳嗽（8週以上持続し胸部X線や喘鳴などの身体所見の異常を伴わない咳）の約半数を占める最多の原因疾患である。本症の病態生理学的特徴を列挙する。

#### a アレルギーの関与

60%の患者で外因性抗原への感作が証明されるが、個々の抗原での陽性率や総IgE値は典型的喘息に比し低い。

#### b 生理学的所見

FEV<sub>1</sub>、PEFなどの気流閉塞指標は正常範囲内のことが多いが、気管支拡張薬が有効なことより、軽微な気道攣縮が咳受容体を刺激して咳を生じると考えられる。気道過敏性は、典型的喘息に比し軽い傾向がある。気流閉塞が軽微なため咳症状が強くても低酸素血症に至ることはまれである。

#### c 病理像

好酸球が喀痰、気管支肺胞洗浄液、気道粘膜で増加し、増加の程度が重症度と相関するため、病態への関与が想定される。気道リモデリングも典型的喘息と同様に存在する。

### 症候・身体所見

咳は深夜や早朝にも認めることが多く、季節性がしばしばみられる。喀痰は伴わないことが多い。喘鳴は自・他覚的に認めず、強制呼出時の呼気終末にも聴取しない（疾患の定義）。上気道炎、冷氣、運動、受動喫煙を含む喫煙、雨天、花粉や黄砂の飛散などで増悪する。

### 診断・検査<sup>1,2)</sup>

欧米で重視される気道過敏性検査は専門性が高く、診断での感度、特異度は100%ではない。 $\beta_2$ 刺激薬の有効性が咳喘息に特異的な所見であり、本剤で咳が改善すれば診断できる（表1）<sup>1)</sup>。ただし慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease：COPD）の咳にも有効であり、喫煙例では留意する。

診察時咳があれば短時間作用性吸入 $\beta_2$ 刺激薬（short-acting  $\beta_2$  agonist：SABA）で即座に有効性を確認できる。夜間の咳が続く場合は長時間作用性 $\beta_2$ 刺激薬（long-acting  $\beta_2$  agonist：LABA、貼付または吸入）を1～2週用いる。当初無効でも、吸入ステロイド薬（inhaled corticosteroid：ICS）による咳改善後の使用で奏効する場合がある。有効性確認を待てない状況では定時ICS+SABA頓用で治療開始してもよい。

喀痰好酸球増多、呼気一酸化窒素濃度（FeNO）上昇は補助診断に有用である。

### 治療と予後<sup>1,2)</sup>

ICS/LABAが基本初期治療薬である。症状が残る既治療例ではICS増量や他の長期管理薬追加を考慮する。重症度に応じて治療開始し（表2）、2～3ヵ月

表1 咳喘息の診断基準：下記1～2のすべてを満たす

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. 喘鳴を伴わない咳嗽が8週間以上持続聴診上も wheezes を認めない                                     |
| 2. 気管支拡張薬（ $\beta_2$ 刺激薬など）が有効                                             |
| 1) 3～8週間の遷延性咳嗽であっても診断できる。3週間未満の急性咳嗽では、安易な診断により感染性/感染後咳嗽への過剰治療にならないように留意する。 |
| 2) $\beta_2$ 刺激薬への反応性には個人差もあり、咳喘息でも無効の場合があるので留意する。                         |
| 参考所見                                                                       |
| (1) 末梢血・喀痰好酸球増多、FeNO濃度高値を認めることがある（後二者は診断的特異度が高い）                           |
| (2) 気道過敏性が亢進している                                                           |
| (3) 咳症状にはしばしば季節性や日差がある。1日のうちでは夜間～早朝にも認めることが多い（夜間・早朝のみの咳であれば咳喘息を強く疑える）      |
| (4) 約半数にアレルギー性鼻炎を合併する                                                      |

FeNO：呼気一酸化窒素濃度。

〔日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2025作成委員会（編）：咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2025，メディカルレビュー社，p108，2025より転載〕